

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LIEGENDE PATIENTEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Malnutrition- und Dehydratationsprophylaxe in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (03/2017) und GS MDS Essen „Essen und Trinken im Alter“ (05/2014)	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Ziele der Maßnahme:

Bei jedem Patienten mit pflegerischem Unterstützungsbedarf ist die orale Nahrungsaufnahme entsprechend seinen Bedürfnissen und seinem Bedarf gesichert und es wird einer drohenden oder bestehenden Mangelernährung entgegengewirkt.

Grobe Anzeichen für einen Nahrungs- bzw. Flüssigkeitsmangel (Screening)

- auffällig niedriges Körpergewicht, zu weit gewordene Kleidung, tief liegende Augen, auf Flüssigkeitsdefizit hinweisende Verwirrtheit, konzentrierter Urin
- unbeabsichtigter Gewichtsverlust in den letzten 3 – 6 Monaten (mehr als 5 % in 1 – 3 Monaten, mehr als 10 % in 6 Monaten)
- Auffällig geringe Ess- und Trinkmengen (Tellerprotokoll, Trinken unter 1,0 l pro Tag über mehrere Tage)
- Erhöhter Energie-, Nährstoff und Flüssigkeitsbedarf bzw. Verluste (z. B. aufgrund von Erkrankungen, außergewöhnlicher Mobilität oder hohen Außentemperaturen, Absorptionsstörungen, starker Blutverlust, Erbrechen heftiger Durchfall)

Bei groben Anzeichen, tiefergehende Einschätzung der Ernährungssituation und der sie beeinflussenden Faktoren (Assessment)

- körperlich oder kognitiv (geistig) bedingte Beeinträchtigung (z. B. Schmerzen, Demenz, Funktionseinschränkungen der Hände oder Arme, schlechter Zustand des Mundes, inadäquater Zahnstatus, Müdigkeit beim Essen)
- fehlende Lust zum Essen/Trinken, kein Appetit, Ablehnung der Speisen, z. B. Schmerzen, Bewegungsmangel, reduzierter Geruchs- und Geschmackssinn, individuelle Abneigungen oder kulturelle/religiöse Gründe
- Ungünstige Umgebungsfaktoren z. B. hoher Geräuschpegel, unangenehme Gerüche, ungünstige Essenszeiten, mangelnde Unterstützung/Hilfsmittelangebote
- Inadäquates Essens- bzw. Trinkangebot, z. B. unangemessene Konsistenz, fehlende Berücksichtigung individueller Bedürfnisse
- Gründe für erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf-/Flüssigkeitsbedarf bzw. erhöhter Verluste z. B. Krankheit, Hyperaktivität
- Vereinsamung, fehlende soziale Kontakte

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Patienten informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Messmittel: Maßband, Waagen, BMI-Rechner

Durchführung:

- die erste pflegfachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Anderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM KLINIKUM KÖLN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Malnutrition- und Dehydratationsprophylaxe in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (03/2017) und GS MDS Essen „Essen und Trinken im Alter“ (05/2014)	

Situationseinschätzung in den Themenfeldern durch die PFK unter der Rubrik relevantes Risiko und Phänomen in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).

- Das Screening insbesondere der Gewichtsverlauf erfolgt bei allen Patienten (SGB XI) **durch die PFK** bei Aufnahme, bei Rückkehr aus dem Krankenhaus, bei akuten sichtbaren Veränderungen jeweils sofort, ansonsten 1 x monatlich um den monatlichen Gewichtsverlauf nachvollziehbar bewerten zu können.
- Das Screening ersetzt keine Krankenbeobachtung und bewertet grobe Anzeichen für Nahrungs- bzw. Flüssigkeitsmangel.
- Wird die Kategorie von der PFK mit „nein“ angekreuzt, liegt aus pflegefachlicher Sicht kein Ernährungsrisiko vor, es werden keine prophylaktischen Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- Wird die Kategorie „ja“ angekreuzt, legt die PFK fest in welchem Abstand diese erneute Bewertung stattfindet
- um festzulegen, ob hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für ein Assessment besteht, sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen und ggf. die Maßnahmenplanung anzulegen bzw. anzupassen
- Treten Ernährungsdefizite als Phänomen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung
- Ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen,
- Bei immobilen Patienten, die nicht gewogen werden können bzw. bei Patienten, die nicht gewogen werden wollen, ist der Umfang des mittleren Oberarmes (OAU) zu messen. Die Nutzung des OAU entbindet nicht von der Krankenbeobachtung (klinische Beobachtung). Liegen Irritationen vor, bspw. sehr dünne Oberarme jedoch der Körper ist in einem guten Ernährungszustand oder anders herum, so nutzt dieses Messmittel nichts. Hier sind dann andere Messmittel bis hin zur allgemeinen Einschätzung des körperlichen Zustandes zu nutzen.
- Die Berechnung des BMI, Oberarmumfangs (OAU) bzw. Wadenumfangs (WU) und des Bedarfs an Energie erfolgt gemäß Anlage (Berechnungsformeln ...)
- bei Patienten (SGB V) **durch die PFK** nur bei Auffälligkeiten (z. B. Kachexie)

Maßnahmen im Ernährungsmanagement können sein:

- Hinsichtlich direkter Ernährungsmaßnahmen haben orale Strategien bei älteren Menschen immer Priorität.
- Bei Notwendigkeit Unterstützung bei der Nahrungsbeschaffung bzw. Nahrungsherstellung insbesondere bei vereinbarten Leistungen zur Ernährung oder als vereinbarte Zusatzleistung.
- Wir ermitteln, respektieren und dokumentieren Informationen zum „biografischen BMI“ unserer Patienten, außer er wünscht eine Veränderung, hierbei unterstützen wir.
- Bei erkannten Gefährdungen ist ein Arzt, eine Ernährungsfachkraft, Diätassistent, Logopäde oder ein Ergotherapeut einzubeziehen. Eine mögliche ergebnis-orientierte Fallbesprechung ist zu dokumentieren.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM KLINIKUM KÖLN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Malnutrition- und Dehydratationsprophylaxe in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (03/2017) und GS MDS Essen „Essen und Trinken im Alter“ (05/2014)	

- Die Bedarfsermittlung für Nahrung (in kcal.) und Flüssigkeit wird durch die PFK (PFK) in Abstimmung mit der Ernährungsfachkraft ermittelt.
- im Einzelfall kann es zur Erreichung des wünschenswerten BMI von 24 – 29 notwendig sein mit dem Patienten eine Mehr- oder Minderkalorienzufuhr zu vereinbaren. Bei Untergewichtigen kann bis zum Erreichen des BMI 24 ein Wert von 10 % der ermittelten Kalorien hinzugerechnet werden, bei Adipösen kann bis zum Erreichen des BMI 29 ein Wert von 10 % der ermittelten Kalorien abgezogen werden. Die Reduktion der Zufuhr von Nahrung soll immer nur unter Beachtung der Gesamtsituation des Patienten erfolgen. Eine Gewichtsreduktion bei Adipösen kann mit unerwünschtem Muskelabbau einhergehen.
- Die im Einzelfall notwendigen Einfuhrnachweise sind anzulegen und über einen Zeitraum von 5 Tagen zu führen und zu evaluieren. Bei Notwendigkeit ist sich mit dem Arzt und der Ernährungsfachkraft abzustimmen.
- Auf den „Einfuhrnachweisen“ sind Informationen des Patienten/Angehörigen zur aufgenommen Nahrung oder Flüssigkeit mit einem „A“ zu kennzeichnen (wenn diese Informationen nicht stimmig sind, können sie in der Summierung nicht berücksichtigt werden), am Tagesabschluss sind die Beträge zusammenzufassen
- Bei wiederholt erkannten Gefährdungen ist ein Beratungsgespräch mit dem Patienten und den Angehörigen über die Gefahren der Mangelernährung und der ordnungsgemäßen Absicherung der Bereithaltung von Nahrungsmitteln in der Häuslichkeit zu führen, „Essen auf Rädern“ ist anzubieten. Diese Beratung ist bei Bedarf zu wiederholen.
- Es ist soweit als möglich darauf hinzuwirken, dass zur Unterstützung der Vitamin D-Produktion Aufenthalte im Freien möglich sind.
- Die Auswirkungen von Erkrankungen, Veränderungen bzw. Einschränkungen auf die Nahrungsaufnahme sind besonders zu berücksichtigen. Hierzu gehört die Mundpflege, die zahnärztliche Betreuung, die Beachtung von Schmerzen im Bereich von Kiefer, Mund, Hals und Magen, motorische und visuelle Beeinträchtigungen, Kau- und Schluckbeschwerden, Diabetes, arterielle Hypertonie (Bluthochdruck), Herzinsuffizienz, chronischer Nierenerkrankung, Fettstoffwechselstörungen (Cholesterin), Adipositas (BMI 30 und höher), chronische Obstipation, Diarrhö, Nahrungsmittelintoleranzen bzw. -allergien,
- Auswirkungen von Medikamenten und Nebenwirkungen sind unter Beachtung von Polypharmazie und dem Alter zu beachten.
- Die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme hat sich aktivierend an den vorhandenen Einschränkungen zu orientieren (bspw. Aspirationsgefahr, Schluckstörungen etc.), soweit möglich ist der Rahmen der Speiseneinnahme angenehm zu gestalten.
- Es sind Vorlieben bzw. Abneigungen gegenüber bestimmten Speisen und Getränken herauszufinden und zu berücksichtigen
- Es ist auf eine ausgewogene Ernährung hinzuwirken, Fehlernährung ist zu vermeiden.
- Bei der Gabe von Nahrung über eine PEG-Sonde soll sich der Patient aufrecht auf einen Stuhl bzw. im Bett aufsetzen. Ist dies nicht möglich soll der Oberkörper hoch gelagert werden. Der Patient soll diese Haltung noch mindestens 30 Minuten nach der Gabe der Nahrung beibehalten.
- **Umgang mit Nahrung/Flüssigkeit in besonderen Situationen:** unter Berücksichtigung festgestellter Ablehnung der Nahrungsaufnahme, von vorliegenden Patientenverfügungen und Äußerungen des Patienten hat die PFK bei Notwendigkeit den Patienten selbst, seine Angehörigen, Betreuer und andere an der Versorgung Beteiligter im Rahmen der Klärung ethischer Fragen in Bezug auf Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme einzubeziehen. Es ist eine Fallbesprechung aus ethischer Sicht durchzuführen und zu dokumentieren. Nahrungsablehnung kann Ausdruck von bewusstem Sterbenwollen oder in Kauf

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Malnutrition- und Dehydratationsprophylaxe in Anlehnung an den Nationalen Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ (03/2017) und GS MDS Essen „Essen und Trinken im Alter“ (05/2014)	

genommenem Sterben sein. Vorher sind alle anderen möglichen Ursachen auszuschließen.

Zusätzliche Hinweise zum Flüssigkeitsstatus:

- **Symptome für Flüssigkeitsmangel sind:** vermehrter Durst, Anstieg der Pulsfrequenz, allgemeine Schwäche, Schläfrigkeit, Lethargie (Lustlosigkeit), akute Verwirrheitszustände, Delir, *schneller Gewichtsverlust*, trockene Zunge, trockene Schleimhäute und Haut, Krampfanfälle, niedriger Blutdruck, konzentrierter dunkler Urin, verminderte Urinausscheidung, fehlender Speichelsee unter der Zunge, pudertrockene Haut, fehlender Fußschweiß, erhöhte Temperatur bzw. Störung der Temperaturregulation, Schwindel/Hypotonie/Tachykardie, Muskelschwäche/Krämpfe besonders in den Beinen, Infektionen, *später Obstipation*, Thrombosen, Lungenembolie, Elektrolytentgleisungen mit Krampfanfällen, anstieg von Harnstoff und Kreatinin
- Die Bewertung des Flüssigkeitsstatus erfolgt mit dem o.g. Screening und Assessment
- Bei erkannten Gefährdungen ist ein Arzt, eine Ernährungsfachkraft, Diätassistentin, Logopädin oder ein Ergotherapeut einzubeziehen, eine mögliche ergebnisorientierte Fallbesprechung ist zu dokumentieren
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf adipösen Patienten, da hier der Hauturgor (Hautspannung) teilweise keinen Rückschluss auf Dehydratation zulässt
- **Besondere Situationen die Auswirkungen auf den Flüssigkeitshaushalt haben können**, sind besonders zu berücksichtigen (bspw. Krankheiten, die mit vermehrtem Flüssigkeitsausstoß einhergehen, Fieber, große körperliche Aktivität, sehr hohe Außentemperaturen – hier sind Hitzewarnungen offizieller Stellen zu berücksichtigen)
- **Maßnahmen zur Zielerreichung von 1,5 l orales Trinken können sein:** Lieblingsgetränk herausfinden, vorhalten und anbieten; gewohntes Getränk bereit halten; unterschiedliche Trinkgefäße ausprobieren; möglichst keine Schnabeltassen verwenden; Getränke befinden sich griffbereit in Reichweite; Eigengewicht der Gefäße beachten; größere Gefäße sind besser als kleinere, Angebote einladend gestalten; Geselligkeit kann förderlich sein; mit den Betroffenen gemeinsam trinken; salzige Getränke wie Brühe oder Bier werden gern getrunken und sind oft besser als süße; Alkohol in geringen Mengen ist erlaubt; beim Trinken unbedingt Zeit lassen; aufrechte Sitzposition einnehmen; Getränkezeiten festlegen(Trinkwecker); Kaffee möglichst frisch brühen, Anbieten wasserreicher Früchte und Gemüse

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Abfall entsorgen
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Ablehnung von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA